doi: 10.3969/j.issn.1672-4933.2025.04.002

我国言语障碍康复治疗发展历程与现状

The Development Process and Current Situation of Rehabilitation Therapy for Speech Disorders in China

陈仁吉

CHEN Ren-ji

【摘要】本文系统介绍了我国言语障碍康复治疗的发展历程、现状与挑战。我国言语康复治疗历经萌芽、体系构建和技术革新3个阶段，学科体系逐步完善。当前仍面临严峻的形势，患者基数大，专业人才严重短缺，且基层覆盖率低；行业挑战突出，包括缺乏国家言语康复治疗师职业认证标准、多学科协作不足、基层人工智能技术应用率低及设备投入不足等。针对上述挑战提出核心对策：加大人才培养，完善教育体系；推动技术创新与科研，推广人工智能应用；加强国际合作；促进跨学科融合，强化言语康复治疗医-教-社协作；完善制度，建立准入标准和医保政策。通过政策指引、技术与协作，构建预防-治疗-康复-社会融入的生态链，提升汉语语言障碍研究的国际影响力，推动我国言语康复行业规范化、专业化发展。

【关键词】言语语言障碍；言语康复治疗

【中图分类号】R493 **【文献标识码】**A **【文章编号】**1672-4933(2025)04-0337-04

【Abstract】This paper systematically introduces the development history, current status, and challenges of speech disorder rehabilitation therapy in China. China's speech rehabilitation has gone through three stages: germination, system construction, and technological innovation, with the disciplinary system gradually improving. The current situation is severe: the patient base is huge, professional talents are severely scarce, and the grass-roots coverage rate is low. Industry challenges are prominent, including the lack of national professional certification standards for speech therapists, insufficient multidisciplinary collaboration, low application rate of artificial intelligence (AI) technology at the grass-roots level, and inadequate equipment investment. In response to the above challenges, core countermeasures are proposed: intensify talent training and improve the education system; promote technological innovation and scientific research, expand AI applications, and strengthen international cooperation; facilitate interdisciplinary integration, enhance medical-educational-social collaboration in speech rehabilitation, improve systems, and establish access standards and medical insurance policies. Guided by policies, technology, and collaboration, a complete ecological chain of prevention-treatment-rehabilitation-social integration will be constructed, the international influence of Chinese speech and language disorder research will be enhanced, and the standardized and professional development of China's speech rehabilitation industry will

陈仁吉，教授，主任医师，博士生导师，国际牙医师学院院士，首都医科大学附属北京口腔医院言语康复治疗中心主任。学术任职：中国康复医学会言语康复专委会主任委员、中国康复医学会口腔疾病预防与康复专委会副主任委员、中华口腔医学会唇腭裂专委会副主任委员、中华口腔医学会口腔颌面外科专委会委员、北京口腔医学会口腔颌面外科专委会主任委员，《International Journal of Speech & Language Pathology and Audiology》《中华口腔医学研究杂志》《中华口腔医学继续教育杂志》编委，国家科委、北京市自然科学基金项目评审专家。承担国家级、省部级科学基金课题7项。发表论文79篇，SCI收录22篇，主编专著《腭裂术后语音训练》、《腭裂语音治疗音像教材》，参编专著11部，参编8年制教科书1部、全国高等学校研究生规划教材1部，获中国康复医学会科学技术奖二等奖1项，获北京市科学技术二等奖1项。

作者单位：首都医科大学附属北京口腔医院言语康复治疗中心 北京 100000

作者简介：陈仁吉 教授 主任医师；研究方向：言语障碍诊断与治疗，腭裂言语障碍发生机制研究，先天性唇腭面裂的序列治疗

通讯作者：陈仁吉，E-mail：chenrenji@126.com

中国知网 https://www.cnki.net

be promoted.

【Key words】Speech and language disorder; Speech rehabilitation

言语障碍(speech disorders)是指由于神经性、器质性或功能性等因素导致的发音不清、嗓音质量下降、发音不流畅或韵律异常等现象,严重影响患者的语言交流与生活质量。言语障碍分为运动性言语障碍、语音障碍(又称构音音系障碍)、发育性语言障碍、嗓音障碍、言语流畅性障碍、吞咽障碍、器质性构音障碍等[1,2]。

1 言语障碍康复治疗的发展历程

我国言语障碍康复治疗的发展历程呈现出从无到有、逐步规范的特点。

1.1 学科萌芽(1970年～2000年)

我国言语障碍康复起步于20世纪70年代末。1979年,北京友谊医院杨和钧教授率先开展嗓音医学研究,设立国内首个嗓音医学门诊,开启嗓音障碍治疗。1983年,中国康复研究中心(现北京博爱医院)成立,引进失语症分类标准并制定行业规范,成为全国首个国家级康复机构。1988年,北京博爱医院开设言语治疗科,李胜利教授担任科主任,标志着临床服务体系的初步建立。1991年,北京医科大学口腔医学院、中国医学科学院整形医院先后成立唇腭裂治疗中心,开展腭裂术后言语障碍康复治疗[1,3~9]。

1.2 体系构建(2000年～2020年)

2004年,华东师范大学设立中国大陆首个言语听觉科学本科专业;2012年,教育部批准听力与言语康复学本科专业(专业代码101008T),正式确认言语语言病理学教育在医学领域的专业名称;2017年,中国残疾人康复协会语言障碍康复专委会成立;2018年,北京语言大学成立国内首个语言康复学院,是国内率先在语言大学开设言语语言病理学专业独立成院的学校;2020年,中国康复医学会言语康复专业委员会在京成立,陈仁吉教授当选首届主任委员,标志着国家级学术平台的建立[1,10~12],在中国言语康复进程中具有里程碑意义,该协会现有105名委员、1100名会员。

1.3 技术革新(2020年至今)

华西医院等开发了AI语音康复系统服务于偏远地区;宁波卫生职业技术学院"康复云"平台整合3D发音模型与远程诊疗[13~18],年服务超3万人次。

2 言语障碍康复治疗的现状

2.1 患者基数与需求

我国各类残疾人总数达8500万,言语语言障碍儿童占儿童总数的10%～20%,其中学龄前儿童约10%患有言语障碍,3～6岁儿童言语障碍发病率3%～8%。我国唇腭裂发病率约1.82‰,其中腭裂术后30%～50%的患者存在言语障碍;每年有150万脑卒中新发患者,其中约30%患有失语症;脑外伤患者的发生率约为55.4/10万/年,其中10%患有失语症和言语语言障碍;脑瘫患者发病率约1.2‰～2.5‰,其中80%伴有语言障碍;嗓音障碍患者发病率约6.6%;发育性语言障碍患儿发病率约7%;口吃患者发病率约1%,其中儿童患者发病率较高,约为3%～4%,目前口吃人数约1400万;我国有听力言语残疾人2780万,其语言沟通能力明显低于正常儿童;我国孤独症谱系障碍患病率约1%,目前患者已超1000万,0～14岁儿童患者200余万人,其中相当数量患儿存在不同程度的语言沟通障碍[19~27]。以上数据显示,我国约有3000万言语障碍人群需要及时的言语康复治疗,其中,急需言语语言康复治疗患者达179万人以上。

2.2 专业人才现状

我国现有言语治疗师总数不足1万人,按我国人口基数及国际标准比例推算需言语治疗师13.48万人,缺口大于12万人。按照每10万人占比预估,我国现有约0.7万言语治疗师,按照美国13.1万人的标准,应有20万言语治疗师,仅为美国的3%。在地域分布方面,省会城市占比48.9%,县级以下占比17.91%,农村覆盖率小于10%。年培养能力约1500人。东南亚13国中仅中国、柬埔寨无言语治疗师执业认证[28~30]。部分国家言语治疗师人数及占人口比例见表1。

表1 部分国家言语治疗师人数及占比

国别	年份	数量(人)	每10万人口占有数(人)
英国	1975	889	1.6
瑞典	1975	273	3.3
西德	1976	361	0.6
法国	1975	6424	12.2
加拿大	1976	1048	4.6
美国	1974	27000	12.6
日本	1984	172	0.14

2.3 人才培养体系

2012年教育部批准设立听力与言语康复学(101008T)、教育康复学(040110TK)本科专业及言语听觉康复技术(520603)专科专业,共26所听力与言语康复学本科院校,17所言语听觉康复技术专科院校,8个硕士、博士点,如华东师范大学、滨州医学院、浙江中医药大学等[4,11]。目前,国内教育机构每年招收培养的言语康复人才约1500人。

中国知网 https://www.cnki.net

3 言语康复面临的挑战

3.1 人才危机

言语治疗师缺口超12万，县级以下资源匮乏。语言康复治疗专业人员严重不足。据统计，我国听觉言语康复师不足1万人（约6860人，其中，言语治疗师700余人）。按照我国现有的培养能力，每年可培养言语治疗师1500人，国际上言语障碍患者与言语治疗师之间的比例是20‰，我国仍需要13.48万言语治疗师[5,19]。

3.2 标准缺失

言语治疗师缺乏国家职业资格认证制度及相应的专业技术准入标准，现有的言语治疗师考核及培训不能代替职业资格考试[2,3,31]。

3.3 学科壁垒

医学、语言学、教育学协作不足，言语康复培养体系不健全，语音病理及言语康复治疗学涉及医学、心理学、语音语言学、教育学、康复学等多学科与专业，是一门年轻的边缘学科，各方重视不足，人才培养体系不健全，开设的专业有待补充，康复研究需拓宽和深入[5]。

3.4 技术落地难

基层AI应用率低，设备投入不足。在言语康复治疗领域，尽管AI技术展现出巨大潜力，但其实际应用率目前仍处于较低水平。首先，专业人才的短缺是制约AI在言语康复中广泛应用的重要因素，操作和维护AI言语康复设备需要专业技术人员，他们不仅要熟悉康复医学知识，还要掌握AI技术原理、数据处理与分析等多领域技能。目前这类复合型专业人才在极为稀缺，现有的言语康复治疗师队伍中，多数人员对传统康复治疗方法较熟悉，但对AI技术的理解和应用能力有限，在一定程度上阻碍了AI设备在康复治疗中的有效推广与运用。设备投入不足是亟待解决的问题，许多康复机构的言语康复设备陈旧、老化，功能单一，无法满足现代康复治疗需求。偏远地区或经济欠发达地区康复机构甚至连基本的言语评估工具都不齐全，配备先进的AI言语康复设备较困难。

3.5 专业人员资质门槛低

言语康复治疗师来源不一，渠道各异，专业水平参差不齐，从业人员3000～5000人来自各行各业，且无相关资质，这一现状亟待改变。

4 发展目标与对策

核心路径：政策驱动+技术普惠+学科融通。

4.1 加大人才培养力度

构建院校教育-职业培训-继续教育3级体系，进一步完善人才培养制度，扩大高校招生规模。目前，大部分言语治疗师培养院校开设的课程主要集中在听力言语障碍方面，难以覆盖其他类型言语障碍，只有完善学科培养体系，才能使言语康复人才不仅数量提升，还能巩固言语康复专业队伍发展壮大的基础。

4.2 技术创新

推广AI辅助系统，建设区域远程康复中心，实现筛查-诊断-治疗-随访全链条数字化，开发汉语言语障碍评估与治疗国际标准。为提升AI在言语康复治疗中的应用率，解决设备投入不足问题，需要多方共同努力。政府部门应加大对康复医疗领域的资金投入和政策扶持，通过专项补贴、税收优惠等方式，鼓励医疗机构引进和更新言语康复设备。此外，医疗机构自身也应重视设备的更新与升级，合理规划资金预算，积极探索与企业合作的模式，共同推动AI技术在言语康复治疗中的广泛应用与发展。

4.2.1 重视科研投入 科研是言语康复发展的基础和动力，只有加强言语康复相关研究，拓宽康复研究范围，才能提高我国言语康复治疗人才科研及临床水平。

4.2.2 国际接轨 加强国际学术交流合作，制定汉语语言障碍国际标准，广泛开展国际性学术交流，与美国言语语言听力协会（American speech-language-hearing association，ASHA）等国际言语康复相关机构互认资质，提升我国在语言障碍临床及研究领域的国际影响力。

4.3 跨学科融合

强化医学-教育-社区协作，通过多学科协作与技术创新，构建言语障碍筛查-治疗-社会融入闭环。近年来，言语康复学科融合探索工作已经有良好的发展趋势。

4.4 科普推广，服务大众

大力普及言语障碍诊治相关科普知识，使更多言语障碍人群得到及时有效的康复治疗。

4.5 完善制度

推动言语治疗师准入制度体系的建立，形成言语治疗师资格考核认证制度，建立国家级言语治疗师准入制度，推进言语康复治疗师培训基地的标准制定及资质认证，完善言语障碍康复治疗医保报销政策，这既是广大言语障碍人群享受国家相关政策福利的基础，也有利于社会和谐。

5 展望

我国言语康复正从规模发展转向质量提升的阶段。随着康复大学等机构的建立、AI技术的普及以及政策支持的加强，预计到2030年，言语治疗师数量将突破3万人，基层服务覆盖率提升至50%，形成预防-治疗-康复-社会融入的完整生态链。通过多学科协作与技术创新，我国有望在汉语语言障碍研究领域形成国际影响力，推动

中国知网 https://www.cnki.net

全球言语康复事业发展，唯有如此，中国的言语康复治疗才能真正走向规范化、专业化，制度化，提高我国言语康复治疗的整体水平，与国际接轨，走向世界，最终达到为大众健康服务的目标。

参考文献

[1] 陈仁吉. 言语康复指南[M]. 北京:人民卫生出版社,2023.3-4.

[2] 燕铁斌,陈文华. 中国康复治疗师岗位能力考核与培训制度专家共识[J]. 中国康复医学杂志,2018,33(6): 623-625.

[3] 陈文华,燕铁斌,范艳萍,等.«中国康复治疗师岗位标准编制指南»专家共识[J]. 中国康复医学杂志,2022,37(1):10-13.

[4] 于萍. 儿童言语语言障碍的研究现状[J]. 中华耳科学杂志,2013,11(3): 408-412.

[5] 陈仁吉. 中国腭裂语音治疗的现状与思考[J]. 国际口腔医学志,2012, 39(1):1-5.

[6] 王国民,朱川,袁文化,等. 汉语语音清晰度测试字表的建立和临床应用研究[J]. 上海口腔医学,1995, (3):125-127,183.

[7] 陈仁吉,王光和,孙勇刚,等. 腭裂术后功能性语音不清分类的初步研究[J]. 中华口腔医学杂志,1995,30(1):17-20.

[8] 陈仁吉,王光和,孙勇刚,等. 腭裂术后语音训练治疗方法的研究[J]. 中华口腔医学杂志,1996,31(4):220-223.

[9] 冯定香,李胜利. 功能性构音障碍的语言治疗[J]. 中国康复理论与实践,1998, 4(2):64-66.

[10] 陈仁吉,王光和,马莲,等. 强化性语音训练在腭裂术后语音治疗中的应用[J]. 实用口腔医学杂志,1999,15(4):266-268.

[11] 万萍. 言语治疗学(2版) [M]. 北京:人民卫生出版社,2018.12-15.

[12] 陈小娟,张婷. 特殊儿童语言与言语治疗[M]. 南京:南京师范大学出版社,2015.11-12.

[13] 刘新怡,田维维,梁文茹,等. 基于递归图分析的腭裂语音鼻漏气自动识别算法[J]. 计算机科学,2020,47(2):95-101.

[14] 张文婧,赵翠,李春林,等. 腭裂言语障碍儿童语言相关脑区灰质形态学分析[J]. 中华口腔医学杂志,2022,57(9):899-906.

[15] 杨林瑞,陈仁吉. 言语治疗结合经颅磁刺激用于腭裂言语障碍康复的可行性分析[J]. 中华口腔医学研究杂志,2024,18(3):195-199.

[16] 郭晶,陈仁吉,张文婧. 非综合征型唇腭裂患者大脑结构与相关功能的磁共振研究进展[J]. 北京口腔医学,2020,28(3):177-180.

[17] Zhang WJ, Zhao C, Sun LW, et al. Articulation-Function-Associated Cortical Developmental Changesin Patients with Cleft Lipand Palate[J]. Brain Science,2023,550(13):1-14.

[18] Yang LR, Mu Y, Zhai YX, et al. Impaired speech input and output processing abilities in children with cleft palate speech disorder[J]. International Journal of Language & Communication Disorders,2024,4: 1-17.

[19] 杨阳,蒋莉萍,刘琼,等. 国内42家医疗机构腭裂术后语音治疗现状调查[J]. 中国口腔颌面外科杂志,2014,12(1): 25-29.

[20] 昝飞,马红英. 言语语言病理学[M]. 上海:华东师范大学出版社,2005. 22-24. [21] 席艳玲,黄昭鸣. 康复治疗师临床工作指南:言语障碍康复治疗技术[M]. 北京:人民卫生出版社,2020.6-8.

[22] 刘思维,邵骏. 嗓音声学分析方法的研究现状[J]. 临床耳鼻咽喉头颈外科杂志, 2022,36(12): 966-970,976.

[23] 刘雪曼. 儿童语言障碍与语言评估[J]. 中国听力语言康复科学杂志, 2019,17(3):161-165.

[24] 王丽燕,杨影,孙喜斌.3-6岁听障儿童语言功能发展特点的研究[J]. 中华耳科学杂志,2015,13(4):592-596.

[25] 李欢. 构音障碍评估研究述评[J]. 中国特殊教育, 2010, (6): 59-64.

[26] 曲春燕. 儿童言语语言障碍与治疗[M]. 北京:北京出版社,2018.11-13.

[27] Moon SJ, Hwang JS, Shin AL, et al. Accuracy of the Childhood Autism Rating Scale: a systematic review and meta-analysis[J]. Dev Med Child Neurol,2019,61(9):1030-1038.

[28] Liu XL, De Villiers J, Ning C, et al. Research to Establish the Validity, Reliability, and Clinical Utility of a Comprehensive Language Assessment of Mandarin[J]. J Speech Lang Hear Res, 2017, 60(3): 592-606.

[29] 刘晓莉,王建红,许琪,等. 语音障碍儿童神经心理发育特征及影响因素分析[J]. 中华预防医学杂志, 2023, 57(3): 356-361.

[30] Sue ASL, Chloe HMA, Elizabeth C, et al. Speech-Language Pathology and Audiology Professions in Asia: Past History and Current Status[J]. Perspectives,2024,9(8):1197-1216.

[31] 张华. 听力师职业资格考试培训教材[M]. 北京:人民卫生出版社, 2019.3-5.

收稿日期 2025-06-15
责任编辑 薛　静

中国知网 https://www.cnki.net